

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Rita González Núñez, Marco Piro, Noelia Fernández Valverde, María Nieves Gómez González, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN:

Se define como el sangrado existente entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz.

Supone el 7-8% del total de las urgencias, siendo sus posibles causas las úlceras gastroduodenales, lesiones agudas de la mucosa gástricas, varices gastroesofágicas, esofagitis, síndrome de Mallory-Weiss, neoplasias, angiodisplasias y otros.

Puede manifestarse como:

- **Hematemesis:** vómito de contenido hemático, sangre roja, marrón o negra en posos de café o
- **Melenas:** heces negras, fétidas, malolientes y pastosas o
- **Rectorragia:** esta forma de presentación es rara y más frecuente en la HDB, pero en el 10% de las ocasiones puede ser secundaria a una HDA, especialmente si esta cursa con inestabilidad hemodinámica

DIAGNÓSTICO:

Se basa fundamentalmente en una historia clínica detallada en los siguientes apartados:

- **Anamnesis:** hábitos tóxicos (alcohol), fármacos gastrolesivos (AINEs), toma de fármacos (hierro oral, sales de bismuto) o de alimentos que modifiquen la coloración de las heces, antecedentes digestivos o episodios previos de HDA, características de la hemorragia (tiempo transcurrido, cuantía, coloración), síntomas previos (vómitos, disfagia, síndrome constitucional, mareo, síncope...), coagulopatías o fármacos anticoagulantes o antiagregantes, cortejo vegetativo, antecedentes personales o familiares de cáncer gástrico...
- **Exploración física:** toma de constantes vitales como TA, frecuencia cardíaca. Estado general del paciente, palidez de piel y mucosas, estigmas de hepatopatía (arañas vasculares, circulación colateral...), equimosis o petequias, exploración abdominal (palpación de masas, zonas dolorosas, irritación peritoneal...), auscultación abdominal (aumento del peristaltismo). **Tacto rectal** para la comprobación de las melenas. Tener presente siempre datos de baja perfusión periférica, estos son: sudoración, disminución del nivel de conciencia, ansiedad, taquipnea...
- **Pruebas complementarias:**
 - **Hemograma.** Atención a la anemia. No es infrecuente la elevación de los leucocitos de forma reactiva al cuadro.
 - **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. Muy importante la **urea:** si hay valores altos superiores a 2-3 veces del valor normal con creatinina plasmática normal es muy sugestivo de HDA. Suele normalizarse a las 48-72h. Es muy raro que una HDA eleve mucho la PCR, si se da este escenario, buscar otras causas para los vómitos oscuros como vómitos de retención.
 - **Coagulación** básica.
 - **Pruebas cruzadas.** Solicitar pruebas cruzadas y reservar concentrados de hematíes entre 2 a 4 unidades en previsión de transfundir sangre y estado clínico del paciente.

- **Enema:** si hay duda sobre unas posibles melenas y el tacto rectal no las aclara.
- **Endoscopia digestiva alta.**

Diagnóstico diferencial

- **Epistaxis o hemoptisis:** importante recordar que pueden ser causa tanto de hematemesis como de melenas (al deglutirse el contenido hemático).
- **Vómitos oscuros (pseudohematemesis):** bebidas de cola, vino, café... o vómitos de retención por oclusión/suboclusión intestinal o íleo paralítico.
- **Pseudomelenas:** por la toma de hierro oral, bismuto, tinta de calamar, morcilla, espinacas, remolacha, regaliz...
- **Hemorragia digestiva baja:** puede también presentarse con melenas, sobre todo si es una hemorragia de intestino delgado o de colon derecho.

Clasificación hemodinámica

Sin repercusión hemodinámica	Con repercusión hemodinámica
• TAS > 100 mmHg.	• TAS < 100 mmHg.
• FC < 100 lpm.	• FC > 100 lpm.
• Ausencia de cambios con el ortostatismo respecto al decúbito.	• Cambios significativos con el ortostatismo.
• Piel seca (normocoloreada y caliente)	• Hipoperfusión periférica (palidez, cianosis, sudoración, frialdad, agitación...)

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
 - Dieta absoluta, control de constantes vitales.
 - Canalización de dos vías venosas de grueso calibre.
 - Sueroterapia (preferentemente con soluciones cristaloides) y control hemodinámico.
 - Oxígeno suplementario por cánulas nasales o según nivel de SatO₂: cánulas nasales, ventimax o ventimax con reservorio.
- **Medidas específicas:**
 - **IBP en bolo:** Pantoprazol 40mg IV.
 - **Reservar concentrados de hematíes:** realizar pruebas cruzadas y reservar (si precisa).
 - **Antieméticos:** metoclopramida (Primperan®) 10mg IV/8 horas u ondasetron 4mg IV. Recomendados si hay náuseas o vómitos.
 - **Sonda nasogástrica:** no está recomendado su empleo de forma rutinaria. Tendría como única utilidad visualizar el contenido gástrico cuando no nos queda claro si ha habido una HDA.
 - **Eritromicina:** se recomienda la administración de un bolo de 250 mg de eritromicina IV como procinético unos 30-120 minutos antes de realizar la endoscopia para aumentar el rendimiento de la misma.
 - **Corrección de la coagulación:** en pacientes tratados con acenocumarol o warfarina habría que administrar vitamina K a dosis de 10 mg IV para intentar la corrección del INR. Si el paciente tiene un INR muy aumentado o está inestable habría que administrar también concentrados de complejo protrombínico (la dosis varía según el INR, pero lo

mínimo a administrar serían 25 UI/ Kg). El INR debería estar por debajo de 2.5 antes de realizar la endoscopia. Si están en tratamiento con anticoagulantes de acción directa el concentrado de complejo protrombínico podría ser útil a dosis de 25 UI/Kg si la hemorragia es importante o el paciente está inestable. La administración de idarucizumab, antídoto del dabigatrán, solo se recomienda en hemorragia exanguinante con riesgo vital.

- **Transfusión de concentrados de hematíes:** valorar la transfusión de concentrados de hematíes si hay inestabilidad hemodinámica, aunque la analítica todavía no refleje anemia importante. Si el paciente está estable, transfundir según resultados analíticos y comorbilidades.
- **Transfusión de plaquetas:** se recomienda si hay menos de 50000 plaquetas y hemorragia activa o en pacientes politransfundidos (>6 concentrados de hematíes).
- **Si sangrado por varices esofagogástricas:** Somatostatina en bolo de 250µg/15min (3 bolos) y posteriormente perfusión continua (6mg/500ml SSF en 24h). Si hay presentes estigmas de hepatopatía o hepatopatía conocida: administrar de 1 a 3 bolos de 250 microgramos de somatostatina y posteriormente en perfusión continua 3 mg de somatostatina en 500 cc de SSF/12h. Está recomendado transfundir solo lo estrictamente necesario en estos casos, pues puede aumentar la presión portal y agravar la hemorragia.
- **Antibiótico.** Está indicado administrar también en urgencias una dosis de antibiótico (p. ej ceftriaxona 1g/ IV) para prevenir un episodio de peritonitis bacteriana espontánea (PBE). En estos pacientes el INR no es un indicador fiable como medidor de la coagulación de un paciente y no debe intentar corregirse a no ser que esté bajo tratamiento con dicumarínicos.
- **Endoscopia digestiva alta:** no siempre se necesita su realización. Existen diversas escalas como la de **Glasgow-Bradchtford** que nos indican la necesidad de la realización de esta según los datos del paciente (con 1 punto o menos, el paciente podría ser dado de alta sin necesidad de endoscopia de urgencia). Se aconseja la realización de la endoscopia tras haberse alcanzado la estabilidad hemodinámica
- **Interconsulta a digestivo.**

Escala de Glasgow-Blatchford

VARIABLE		PUNTOS
• Urea plasmática (mg/dL)	• $\geq 38 < 47$ • $\geq 47 < 58$ • $\geq 58 < 147$ • ≥ 147	• 2 • 3 • 4 • 6
• Hemoglobina (g/dL) Varones (V). Mujeres (M)	• V: $\geq 12 < 13$ M: $\geq 10 < 12$ • V: $\geq 10 < 12$ • M y V: < 10	• 1 • 3 • 6
• TAS (mmHg)	• 100-109 • 90- 99 • < 90	• 1 • 2 • 3
• Otros	• FC ≥ 100 lpm • Presentación con melenas • Presentación con síncope • Enfermedad hepática previa • Fallo cardíaco	• 1 • 1 • 2 • 2 • 2

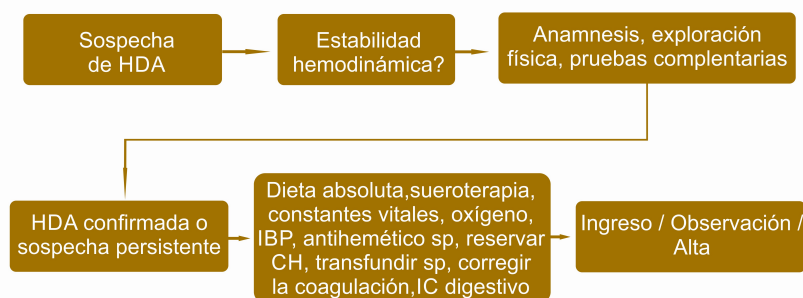
Figura 1: Escala de Glasgow-Blatchford: Riesgo bajo ≤ 1 punto

- Si puntuación menor o igual a un punto en la escala de Glasgow-Blatchford no precisa endoscopia digestiva alta y no sería necesario realizar interconsulta a digestivo.
- Si inestabilidad hemodinámica a pesar de resucitación o disminución del nivel de consciencia habría que realizar interconsulta a UCI.

Criterios de Ingreso

- **Observación/Alta:** estabilidad hemodinámica y ausencia de comorbilidades, valores analíticos normales, diagnóstico endoscópico con estigmas de bajo riesgo de resangrado (Forrest IIc-III para ulcus gastroduodenal), diagnóstico endoscópico con ausencia de sangrado.
- **Ingreso hospitalario:** pacientes aóseos, con comorbilidades, hemorragia recurrente/persistente, inestabilidad hemodinámica, enfermedades concomitantes, hemorragia por hipertensión portal.

Algoritmo



BIBLIOGRAFÍA

- Arrieta Ortubay E, Algara San Nicolás M y Yela San Bernardino C. Hemorragia digestiva. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Editores: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J et al. 8ª edición. MSD; 2016: p901-925.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ªed. Madrid. Elsevier; 2015: p283-289.
- Rodríguez García MC, Fernández-Samos Gutiérrez R. Criterios de actuación en Urgencias. León: EOLAS Ediciones; 2014, p161-163.
- Stanley AJ, Lain L. Management of acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ: 2019; 364:l536.
- Montoro Huguet MA, García Pagán JC. Nuevo manual de emergencias en gastroenterología y hepatología. 2019. Internet: <https://urgenciasgastroenterologia.ec-europe.com/>
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias. 5ªed. Editorial Médica Panamericana; 2017.
- Savides TJ, Jensen DM. Hemorragia digestiva. Sleisenger y Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. 10ª edición. Elsevier; 2017: p297-335.
- Rodríguez Rodríguez M, Montejano Ortega L. Hemoterapia. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Editores: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J et al. 8ª edición. MSD; 2016: p1387-1394.